

NOTULEN

HARI / TANGGAL : JUMAT / 19 JUNI 2026
 PUKUL : 13.00 – 16.00
 AGENDA RAPAT : RAPAT KOORDINASI JUNI 2026

PEMIMPIN RAPAT : Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep,M.Kep
 NOTULIS : arindha rahma putri
 TEMPAT : R. Meeting Sekre Lt. 3

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	PMK no 6 Tahun 2026	Rumah Sakit dikategorikan berdasarkan kompetensi, saat ini RSPHS masih memenuhi dasar dan target ke utama	- Perbaikan regulasi bertahap setelah akre mengikuti kebijakan terbaru - Bulan juli target all unit sudah Menyusun proker dengan mempertimbangkan pemenuhan rs utama	Manajemen, all staf
2.	Pelaporan IKP	Pelaporan IKP masih rendah, staf belum patuh dalam pelaporan	Pelaporan IKP dapat ditingkatkan dan disosialisasikan ulang Pelaporan KPC, KNC ditingkatkan juga	All unit, pmkp
3.	Farmasi	1. pengambilan resep belum sesuai standart waktu penyelesaiannya (racikan dan non racikan) >> penumpukan pelayan resep di waktu yang sama 2. banyak komplain obat racikan yang lama, sudah pengajuan untuk pembeda penyelesaian obat racikan dan non racikan blm ter TL 3. staf belum sepenuhnya terampil 4. revisi racikan di simrs dan tampilan obat racikan belum sesuai dan perlu diperbaiki	1. koordinasikan lebih lanjut untuk penyelesaian kendala 2. buat FMEA racikan, dan TL ke programmer untuk dashboard yg dibedakan 3. diagendakan untuk pelatihan sediaan non steril (segera diajwalkan) 4. ajukan ke programmer segera di TL	Kabid jangmed, farmasi Farmasi, programmer Kains farmasi Farmasi, programmer
4.	IRNA 3A	1. penulisan dokumen medis pasien belum sesuai tindakan yg dilakukan (belum dilakukan tindakan, namun sudah ditulis >> tidak realtime dan tidak sesuai)	1. penulisan wajib disesuaikan tindakan, bukan mengarang	All unit

		2. pemberian obat tidak dilakukan verifikasi	2. setiap memberikan wajib dilakukan verifikasi, tidak ditunda >> lakukan sesuai SPO	All unit
5.	LABORAT	1. Inputan TCM masih terkendala, belum sesuai 2. Tambahan pemeriksaan dari IGD lebih dari jam ketentuan dilakukan sampling ulang	1. buat SPO penginputan pemeriksaan TCM (deadline spo hari ini clear) 2. ketika pasien sudah di ruangan, igd hubungi ruangan untuk diminta sample ulang	Lab, jangmed All unit, lab
6.	RADIOLOGI	dr novita sering minta bacaan ulang dan disesuaikan advice dr novita	Pengantar saat input harus lengkap, permasalahan dr novita coba dikaji	Kabid jangmed, radiologi
7.	MATERNITAS	1. Doppler masih belum bisa digunakan 2. Jika di IRNA ada Pasien nifas dan hamil lakukan konsul juga ke obgyn	1. Buat berita acara kerusakan dan pengajuan ulang 2. IRNA koord dengan bidan jika ada pasien tsb, dan tanyakan ke dpjp utama apakah perlu konsul obgyn (saling koordinasi)	Maternitas All IRNA, mater
8.	GIZI	Pasien pulang belum terhapus, sehingga sisa makanan meningkat	Ketika pasien pulang/ rujuk/meninggal mohon di cek segala administrasinya	All staff
9.	IRNA 2A	Kehilangan selimut	Pengecekamn inventaris ruangan mnjdi tanggung jawab ruangan dan unit	All staff
10.	IGD	1. Kelengkapan verifikasi di ruangan oleh perawat IGD belum terrecord 2. Kebersihan dan kerapian di ruangan masih kurang	1. Koord dengan programmer untuk penyelesaian DPO, agar kelengkapan verifikasi ruangan bisa terecord 2. Remind dan staf wajib tanggung jawab setelah menggunakan bmhp dan alkes	Igd, programmer All igd
11.	RM	1. Pengadaan lembar rekam medis 2. Penyimpanan rekam medis masih belum rapih 3. APM kendala pada pasien lansia tanpa handphone, sehingga tidak bisa mnnggunakan mobile jkn 4. SEP HD yang tidak terbit, karena human error dan belum terbridging	1. Follow up ke pengadaan 2. Dirapihkan segera 3. – 4. Lakukan double check, dan ketelitian ditingkatkan. Serta follow up untuk proses bridging dipercepat	Karu RM All Rekam Medis - PIC APM

12.	IRJA	1. Keterlambatan DPJP masih tinggi 2. Dispenser masih terkendala 3. Kresek di poli estetika masih belum ada brandingnya 4. Akrilik dokter papan nama	1. Remind untuk jadwal dpjp, kabid yanmed remind keterlambatan dpjp 2. Koord dengan pengadaan 3. Ajukan dan follow up pemenuhannya 4. Ajukan yang bagus	Kabid yanmed, karu irja Karu irja Karu irja, pic poli estetik Karu irja, pkrs
13.	ICU	Lembar koran observasi icu habis	Followup ke pengadaan dan sampaikan stok saat ini	Karu icu
14.	CSSD	1. IKO sering meninggalkan limbah linen (masker dll) 2. Tidak semua staf di unit yg paham pengiriman alkes ke cssd yg sesuai	1. Diperhatikan Kembali 2. Karu sosialisasi ulang terkait SPO pengriman alkes ke cssd	IKO Karu cssd, all unit
15.	PMKP	1. Pelaporan IKP msih rendah, budaya pelaporan masih kurang, pemahaman terkait ikp juga belum paham 2. Feedback form pelaporan 3. Belum tertibnya pic data unit untuk melaporkan data IMPRS dan IMP unit secara realtime 4. Beberapa unit belum patuh dalam pengisian CP, sehingga variasi dalam CP belum dapat dipetakan secara maksimal 5. Kepatuhan penandaan operasi di tubuh pasien masih rendah	1. Sosialisasikan dan agendakan Pelatihan terkait IKP, karu supervise pic mutu 2. IKP dilaporkan melalui simrs, kalau ktd sentinel menggunakan form karena kronlogi Panjang >> tetap dijalankan dua form hardfile dan simrs (sesuai yang sudah ditampilkan saat rapat) + adakan sosialisasi ulang 3. Karu monev pic data untuk pelaporan mutu setiap harinya 4. Sosialisasi ulang terkait pengisian PPK CP, Mutu dan Unit koordinasi terkait variasi CP dgn casemix manajer 5. Karu dan unit remind dokter untuk kepatuhan penandaan operasi terutama pada daerah op yang memiliki 2 sisi	Pmkp, karu, pic mutu All staf Karu, pic unit Karu, komite mutu, casemix manajer Unit IKO. komdik
16.	PPI	1. pengambilan instrumen bersih dan pengiriman instrumen kotor ke CSSD tanpa menggunakan box yang tertutup	1. penurunan instrumen kotor ke unit CSSD harus dan wajib menggunakan box kotor dengan posisi terendam dan	ALL UNIT



			dilakukan serah terima dengan staff CSSD untuk mengecek kondisi alat. untuk pengambilan instrumen bersih menggunakan box bersih. jam pengiriman instrumen kotor (08.00-09.30 , 13.00-14.30 , 19.00-20.30) dajm permintaan instrumen (09.30 - 11.00 dan 15.00-18.00). semua barang ED yang ada di unit wajib dilakukan supervisi oleh karu dan PIC PPI dan bila di temukan barang ED contoh bagging/RL set silahkan di bawak turun untuk di lakukan dekontaminasi ulang	
		2. pengiriman sampel darah ke lab masih ditemukan tidak menggunakan box pengiriman sampling	2. pengiriman sampel ke LAB wajib menggunakan box yang tertutup	ALL UNIT
		3. BHP spill kit yang sudah terpakai belum di supervisi unit	3. kelengkapan BHP spillkit ikut penginputan unit, kecuali sarung tangan karet/kacamata google ikut komite PPI	ALL UNIT, PIC PPI
		4. laporan PPI yang di isikan oleh unit belum sepenuhnya secara on time terutama pelaporan suhu	4. pelaporan unit wajib dilakukan setiap hari dan di cek oleh Karu unit. bila PIC libur atau off bisa dilakukan oleh kepala jaga. pemngisian suhu bisa dilakukan semua orang. untuk link komite PPI bisa di letakkan di komputer ruangan untuk mempermudah pengisian dan pelaporan	ALL UNIT
		5. kebersihan dan kerapian unit yang belum sesuai dengan standart. perbaikan unit belum semua tersampaikan ke komite PPI utuk pembuatan ICRA/PCRA	5. kebersihan dan kerapian unit menjadi tanggung jawab unit terkait. semua pembersihan yang tidak sesuai bisa di koordinasikan dengan CS unit dan di supervisi. bila terjadi perbaikan unit	ALL UNIT

			silahkan koordinasi dengan komite PPI untuk penerapan ICRA.	
17.	PKRS	Pelaporan edukasi sudah baik kecuali IKO	IKO dan PIC unitnya disupervisi untuk tertib melakukan edukasi sesuai target	PIC IKO
18.	MANRISK	1. Pada bulan Juni ini terdapat peningkatan dalam pemeliharaan alat, yang sebelumnya hanya 1 alat saja, sekarang bisa dilakukan hingga 2 alat, namun jumlah pemeliharaan ini belum mewakili seluruh alat. Hal ini dikarenakan mendahulukan kegiatan untuk perbaikan alat vital. Selain itu kendala dari ATEM adalah pemeliharaan pada alat lain yang vital di unit selain radiologi 2. Dari bulan kebulan, hasil kembali berkas dari pengajuan klaim semakin menurun hingga pada Bulan April penurunan mencapai 7% mendekati nilai standar	1. Supervisi dan audit pemeliharaan alat di radiologi, Supervisi penggunaan alat radiologi 2. Supervisi dan pendampingan dari Tim Asuransi Center, Penyebaran Tim Asuransi di berbagai unit	

Pemimpin Rapat



(Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep,M.Kep)

Pasuruan, 19 Juni 2026

Notulis



(Arindha Rahma Putri, S.Psi)

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M. Kep	RSPHSKR	Direktur RSPH Sukorejo		
3	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	RSPHS	Kabid Jang Med		
4	Sisca Puspitasari, S. Kep. Ns.	RS Prima Husada Sukorejo	Kabid Pelayanan		
5	Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz	RSPHSKR	Kepala Instalasi Gizi & Dapur RSPH Sukorejo		
6	Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz	RSPHSKR	Kepala Instalasi Gizi & Dapur RSPH Sukorejo		
7	Fina Fitriana Dwi Nur, Amd.RMIK	RSPHSKR	Kepala Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran RSPH Sukorejo		
8	Galih Satria Mahardika, S.Pd	RSPHSKR	Kepala IT & SIMRS		
9	Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRJA RSPH Sukorejo		
10	Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRJA RSPH Sukorejo		
11	Ninis indrawati	RSPHSKR	Kepala Ruang Maternitas RSPH Sukorejo		
12	Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns	RSPHSKR	Kepala Ruang NICU RSPH Sukorejo		
13	Ahmad Yasin, S.Pd	RS Prima Husada Sukorejo	Pendaftaran		
14	Nisfil Fitria , Amd.Kep	Ima 3B RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
15	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	Zaifatus Saila, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
17	Zaifatus Saila, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
18	Shafira Rahmanissa, S.KM	k3rs	PESERTA		
19	Elza safarina ulfa		PESERTA		
20	Adinda riza febrianti,A.Md.,Kes	Radiologi	PESERTA		
21	Allamul angga gilang nishvu ramadhan S.Kep., Ns	RSPHSKR	warga		



DOKUMENTASI

